

心肺復甦術(成人與青少年)及使用自動心臟電擊去顫器(以下簡稱 AED)

(一)胸外按壓、AED(第 1 次分析前)：

1. 壓胸者：以目視方式將 1 手掌之根部置於兩乳頭間胸部之中央或中段，另 1 手掌之根部置於前 1 手之上面使雙手重疊及平行，手臂打直，雙肩向前傾至手部之正上方，利用上半身之重量向下按壓，「胸部按壓」操作要領如下：

(1)下壓深度至少為 5 公分(有電擊器品質貼片監測時，按深度應為 5-6 公分)。

(2)每次按壓後必須放鬆讓胸部全回彈。

(3)壓與放的時間各佔 50%。

(4)按壓速度每分鐘 100-120 次。

(5)連續按壓至 AED 第 1 次分析。

(6)AED 分析時應立即中斷任何碰觸病人之動作，壓胸者雙手呈按壓姿勢懸停於病人胸廓上方，俾於不建議電擊時立刻進行按壓。

2. 通氣者/AED 操作者：開啟 AED 電源，將貼片貼在病人身上(部分機型需操作插入 AED 插頭之動作)，於 AED 語音作動時，不接觸病人。

(二)若第 1 次分析為不建議電擊時，不須評估，立即 CPR 2 分鐘；若為建議電擊(AED 充電過程，確認無人接觸傷病患，AED 指示燈閃爍立即按下電擊鈕)，電擊後，不須評估，立即 CPR 2 分鐘。

(三)胸外按壓、AED(第 2 次分析前)：

1. 壓胸者：

(1)繼續按壓，第 1 次按壓配合 30：2，按壓至第 20 下時喊出(20、21...30)，以提醒通氣者準備進行強迫給氧。

(2)於通氣者 3 秒給 2 口氣期間，壓胸者同時默數 3 秒後繼續進行胸部按壓。

(3)原則於第 2 循環按壓開始，通氣者準備至置入 SGA 期間，壓胸者連續按壓，直至通氣者置入 SGA 後進行通氣確認。

2. 通氣者：

(1)取出 BVM，組裝球體及面罩。

(2)吹氣前檢查病人呼吸道是否有阻塞物(必要時清除)。

(3)在壓胸者進行按壓過程聽到「20……」時，準備將 BVM 罩在病人口鼻並維持呼吸道暢通，俟壓胸者按壓至第 30 次時，擠壓 BVM 2 次(得以拇指與 3 指按壓球體約 1/4)，通氣勿過量，2 口氣約 3 秒鐘(每 1 口氣間隔 1 秒)。

(4)連接氧氣導管(同時確認儲氣袋已接妥並充滿)，將氧氣調整至 15L/min。

(5)準備 SGA 過程(選擇適當 SGA、將 BVM 與面罩分離)，提醒壓胸者連續按壓不中斷。

(6)處置過程詢問病史。

(四)置入 SGA 後：

1. 壓胸者：

(1)通氣者請壓胸者暫停壓胸時，壓胸者雙手呈按壓姿勢懸停於病人胸廓上方。

(2)俟通氣者確認 SGA 通氣成功後，仍持續胸部按壓，直至通氣者將 SGA 固定完成。

2. 通氣者：

(1)SGA 置入完成後，將 BVM 連結 SGA，請壓胸者暫停壓胸，並給予 1 次通氣測試(確認兩側胸部有起伏)，隨即固定 SGA。

(2)如無法成功置入 SGA，則改以口咽呼吸道。

(五)壓胸者連續按壓，通氣者維持每 6 秒給 1 口氣。

(六)AED 第 2 次分析，準備搬運病人離開前，應注意事項：

1. 第 2 次 AED 指示電擊並執行後，立即將病人搬至救護車上持續 CPR。若因故停留較久，搬運移動前如 AED 指示電擊，仍應執行電擊後再搬動。

2. 第 2 次 AED 指示不電擊後，檢查病人脈搏(若心律為 asystole 則不需檢查)。

(1)若有脈搏時，檢查呼吸，並給予適當氧氣治療及其他處置，立即將傷病患搬至救護車。

(2)若無脈搏時，立即將傷病患搬至救護車上並持續 CPR。

註：SGA 置入後，壓胸者原則持續按壓，通氣者每 6 秒給 1 口氣，準備將病人搬運離開現場時，倘現場僅 2 名 EMT，始可執行 30:2，另 1 人收拾器材。

3. 針對需要 CPR 之傷病患，搬運過程中應儘量減少胸部按壓中斷時間；若搭乘電梯時，應優先考量穩定性及施救者之安全。

4. 針對已經插管或置入 SGA 之病人，在搬運過程中為防止呼吸道滑脫，可暫時分離 BVM 或使用延長蛇管。

5. 已使用 PAD 者，將 PAD 連同病人搬運至救護車上。